RESUMEN INFORMACION SOBRE CALIDAD DE SUTRAS Y EL IMPACTO EN LA SALUD DE ATENCION HOSPITALARIA; SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE SUTURAS.

Las **suturas quirúrgicas de baja calidad** ejercen un impacto negativo y directo en la estancia hospitalaria de los pacientes. El uso de insumos deficientes incrementa exponencialmente el riesgo de complicaciones postoperatorias, transformando cirugías programadas de corta estancia en ingresos prolongados. Los estudios clínicos demuestran que una **Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ)**—la consecuencia más común de materiales deficientes o fallas técnicas—**prolonga la estancia hospitalaria un promedio de 9.7 días adicionales**, elevando drásticamente el costo financiero por admisión.

A continuación, se detalla un desglose técnico y clínico de cómo los defectos materiales influyen de forma directa en el retraso del alta médica:

1. Fallas del material y cascada de complicaciones clínicas

Defecto de la sutura de baja calidad	Consecuencia clínica inmediata	Mecanismo de prolongación de la estancia
Pérdida prematura de resistencia tensil	**Dehiscencia de la herida** (apertura espontánea de los bordes)	Obliga a realizar curas complejas diarias, desbridamiento quirúrgico en quirófano o Re intervenciones de cierre secundario.
Superficie rugosa e irregularidades	**Trauma tisular** al arrastrar el hilo a través del tejido	Produce isquemia de los bordes y necrosis celular, extendiendo la fase inflamatoria y retrasando el alta.
Materiales mal purificados o tóxicos	**Reacción a cuerpo extraño exacerbada**	Genera inflamación crónica, formación de **seromas o hematomas** que requieren colocación de drenajes y vigilancia médica continua.
Capilaridad e imperfección en multifilamentos	**Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ)**	Las bacterias se alojan en los intersticios del material, protegidas del sistema inmune, requiriendo terapia antibiótica intravenosa obligatoria de varios días.

2. Factores de retención del paciente en el hospital

El incremento en los días de cama responde a necesidades clínicas específicas derivadas de la sutura deficiente:

- **Esquemas de antibioticoterapia intravenosa:** La presencia de infecciones profundas o del sitio operatorio exige el uso de antibióticos por vía endovenosa, requiriendo que el paciente permanezca hospitalizado únicamente para cumplir el tratamiento.

- **Manejo avanzado de heridas abiertas:** Tras una dehiscencia, el paciente no puede recibir el alta hasta que la herida esté limpia, sin signos de sepsis sistémica y con un plan de curas ambulatorias o terapia de presión negativa (VAC) ya establecido.
- **Dependencia de Re intervenciones:** Los eventos catastróficos, como la dehiscencia de suturas internas (ej. fugas anastomóticas en cirugías abdominales), fuerzan cirugías de emergencia, lo que reinicia por completo el contador de días de recuperación crítica.

3. Impacto en la gestión hospitalaria

Para las instituciones de salud, la decisión de adquirir insumos de bajo costo suele generar el efecto inverso en la economía hospitalaria:

- **Disminución del índice de rotación de camas:** Un paciente que cuadriplica su estancia por complicaciones evita el ingreso de nuevos procedimientos programados, saturando los servicios de hospitalización.
- **Elevación de costos indirectos:** El uso prolongado de analgésicos, materiales de curación adicionales, exámenes de laboratorio (monitoreo de leucocitos, cultivos) y horas de enfermería sobrepasan con creces el ahorro inicial del insumo médico.

EN EL REINO UNIDO, LAS INVESTIGACIONES RESPALDADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (NHS) ANALIZAN DE FORMA ESTRICTA LAS COMPLICACIONES DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS, MIDIENDO CON PRECISIÓN CUÁNTOS DÍAS DE ESTANCIA EN CAMA Y QUÉ COSTES FINANCIEROS LE GENERA AL SISTEMA EL USO DE MATERIALES CONVENCIONALES O FALLAS DE CIERRE.

Los estudios británicos clave sobre las complicaciones por suturas, infecciones y estancia hospitalaria demuestran lo siguiente:

1. El impacto bruto en los días de estancia (Estudio de Unidad Vascular del NHS)

Un estudio clínico observacional llevado a cabo en una **unidad de cirugía vascular de un hospital docente del NHS** cuantificó la diferencia neta en la hospitalización de los pacientes que desarrollan una Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ), complicación estrechamente ligada a las propiedades bacterianas de los hilos:

- **Prolongación de la estancia:** Los pacientes que no presentaron complicaciones tuvieron una estancia hospitalaria media de **6.52 días**. En contraste, aquellos con infecciones postoperatorias promediaron **16.24 días** en el hospital.

- **Retraso neto:** La complicación en la herida quirúrgica sumó de forma directa **9.72 días adicionales de internación**.
- **Coste por cama del NHS:** El estudio estimó el coste de hospitalización por infección dentro del NHS en **£333.76 libras por día**, dictaminando que cada episodio de complicación cuesta un aproximado de **£3,244 libras adicionales** solo en estancia en planta.

2. El coste macro de los retrasos en la cicatrización

Investigaciones epidemiológicas británicas a gran escala publicadas en portales especializados como *Wounds UK* evalúan el impacto financiero derivado del retraso en la curación de heridas quirúrgicas (que incluye dehiscencias mecánicas de sutura e infecciones):

- **Carga financiera anual:** El coste anual estimado para el NHS únicamente para gestionar el retraso en la curación de heridas quirúrgicas oscila entre **£957.4 millones y £985.8 millones de libras**.
- **Gasto priorizado:** Las heridas quirúrgicas representan entre el **18.9% y el 21.8% de todo el presupuesto** que el Reino Unido destina al cuidado general de heridas, convirtiéndose en la complicación de tejidos más cara de tratar para el país.

3. Soluciones institucionales del NHS: Suturas con tecnología antibacteriana

Para reducir los días de estancia en cama y disminuir las tasas de reoperaciones para retirar material de sutura infectado, múltiples subdivisiones del NHS (como los fideicomisos hospitalarios de *Cheshire & Merseyside*) han implementado programas de estandarización utilizando **suturas antibacterianas de alta tecnología** (recubiertas con triclosán, conocidas en la literatura médica como *Plus Sutures*).

- **El proyecto PreciSSIon:** Un proyecto colaborativo de gran alcance implementó un paquete de cuidados que incluía el uso obligatorio de suturas antibacterianas de alta calidad. Como resultado, la tasa regional de infecciones en procedimientos seleccionados **se redujo drásticamente del 18% al 9.5%**.
- **Ahorros en salud:** Esta mejora previno que más de 115 pacientes sufrieran complicaciones en sus heridas, generando un ahorro directo de **£566,720 libras** para el hospital al evitar hospitalizaciones prolongadas y reingresos.

4. Conclusión

- Reactivar la promoción en hospitales tipo III y IV.
- Hacer hojas de evaluación en servicios de cirugía, quirófano y emergencia.
- Conseguir carta de exposición de motivos del director del hospital.
- Una vez obtenida esta información hay que consignarla ante el IVSS, Corpovex y el Ministerio.

N°	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO PARA PAGOS EN BS EXPRESADO EN USD CORPOVEX	
1	SUTURA CATGUT CROMICO 2-0 REF (811)	811	USD	18,12
2	SUTURA CATGUT CROMICO 3-0 REF (122)	122	USD	18,12
3	SUTURA CATGUT CROMICO 0 REF(812)	812	USD	16,80
4	SUTURA NYLON 3-0 AGUJA CORTANTE REF (627)	627	USD	21,60
5	SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 2-0 REF(8623)	8623	USD	21,60
6	SUTURA PROLENE (POLIPROPILENO) 3-0 REF(8622)	8622	USD	21,60
7	SUTURA SEDA 3-0 REF (833)	833	USD	18,00
8	SUTURA SEDA 1 REF (835)	835	USD	18,00
9	SUTURA SEDA 0 REF (844)	844	USD	18,00
10	SUTURA VICRYL (POLIGLACTINA) 3-0 REF (316)	316	USD	24,00
11	SUTURA VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 0 REF (340)	340	USD	22,80
12	SUTURA VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 1 REF (341)	341	USD	22,80
13	SUTURA VICRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) 2-0 REF (317)	317	USD	22,80